

Сакрокольпопексия

Информация для пациента · Надёжная операция с сеткой при пролапсе верхушки влагалища

WARWIKI

Сакрокольпопексия — одна из наиболее надёжных операций при пролапсе (опущении) **верхушки влагалища или матки**. Мягкая сетка поднимает верхушку влагалища и фиксирует её к прочной связке у крестца, восстанавливая нормальное положение и глубину. Операция обычно выполняется лапароскопически или роботически (через небольшие проколы) и сохраняет возможность половой жизни.

Об этой операции

Кусок **сетки** пришивается к передней и задней стенкам верхушки влагалища, а затем фиксируется к прочной связке у **крестца**. Это удерживает влагалище в нормальном положении. Операция считается **золотым стандартом** при апикальном пролапсе благодаря долговременному результату.

О сетке

Сетка устанавливается через **брюшную полость** и имеет хорошо изученный профиль безопасности. Она **принципиально отличается** от трансвагинальной сетки при пролапсе, в отношении которой FDA выпускало предупреждения и которая снята с рынка. Хирург обсудит с вами небольшие риски, в том числе редкую возможность обнажения сетки.

ТЕРМИНЫ

Апекс / свод влагалища

Верхушка влагалища, которая может опускаться после родов или удаления матки.

Крестец

Кость в основании позвоночника; её связка служит опорой для фиксации.

Сетка

Мягкий постоянный материал для поддержки верхушки влагалища.

Роботическая / лапароскопическая

Операция через небольшие проколы.

Обнажение сетки

Редкое осложнение, при котором небольшой участок сетки становится видимым; поддаётся лечению.

Гистерэктомия

Удаление матки, которое иногда выполняется одновременно.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под общей анестезией, поэтому вы ничего не чувствуете. При лапароскопическом доступе большинство пациентов отмечают умеренную болезненность в области проколов и дискомфорт от газов; выписка — в тот же день или на следующее утро. При открытой операции восстановление займёт чуть больше времени.

Как подготовиться

- Операция под **общей анестезией** — соблюдайте режим голодания и инструкции по препаратам (отмена антикоагулянтов по назначению врача).
- Предоперационное обследование; одновременно может быть выполнена **гистерэктомия** и/или операция по поводу недержания мочи.
- Не курите; организуйте транспорт домой и помощь в первые дни.

Что происходит

- 1 Вы засыпаете; вводится профилактический антибиотик.
- 2 Через небольшие проколы (или один открытый разрез) сетка пришивается к верхушке влагалища.
- 3 Сетка фиксируется к крестцовой связке, поднимая влагалище на место.
- 4 На короткое время устанавливается катетер.

После операции

- Выписка в тот же день или на следующее утро; сначала — лёгкая активность.
- **Избегайте тяжёлых нагрузок, натуживания и половой жизни около 6 недель.**
- Небольшие выделения и умеренный дискомфорт — норма; следите за стулом, не допускайте запоров.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- Обильное кровотечение или усиливающаяся боль в животе или тазу
- Вы **не можете помочиться** или сохраняется тошнота/рвота
- Выделения с запахом или боль при половом акте впоследствии (возможная проблема с сеткой)

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Сакрокольпопексия поднимает верхушку влагалища с помощью сетки, фиксированной к крестцу — наиболее надёжная операция при апикальном пролапсе, обычно лапароскопическая.
2. Брюшная сетка хорошо изучена и принципиально отличается от отозванной трансвагинальной сетки.
3. Избегайте нагрузок и половой жизни ~6 недель. Звоните врачу при температуре, обильном кровотечении, невозможности мочиться или появлении выделений с запахом/боли.